EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 72560
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-10-17 11:04:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ELIANA DEL C MARTINEZ RODRIGUEZ			RUN	: 7.643.783-1
F.Nac	: 02-01-1952	Edad	: 71 AÑOS, 9 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: BRASIL 1060			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 412224		
Fecha Ingreso	: 2023-09-24	Fecha Egreso	: 2023-10-17 11:04:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I63.3-INFARTO CEREBRAL DEBIDO A TROMBOSIS DE ARTERIAS CEREBRALES

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- ACV territorio superficial y profundo de ACM M1 izquierdo cardioembólico. Día 23. Trombectomía frustra.
- Vejiga neurogénica. Retención urinaria.
- ITU E faecium resistente a vancomicina tratada 7 días Linezolid
- Traqueobronquitis, E asburiae, K oxytoca, E kobei tratada
- Coxoartrosis
- Antecedentes: FA en tratamiento con Dabigatran - ACV parietal posterior izquierdo no secuelado 2017 - Insuficiencia cardiaca - Hipertensión arterial - Diabetes mellitus tipo 2 NIR - Asma bronquial - Hipertiroidismo

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Diestra mRS0
Paciente ultima vez vista bien el 22/09/23, encontrada el 23/09/23 a las 6:30 horas con alteración del lenguaje y debilidad severa derecha. Traslado SAMU a HSC.
Al ingreso en SU de HSC con FC 80 lpm, PA 133/94 mmHg, Sat 98%, HGT 108 mg/dL, T° 36.7°C. Se describe al examen afasia, PFC derecha y hemiplegia derecha. Se complementó estudio con TC de encéfalo sin contraste en que se evidenció lesión secuelar antigua parietal posterior izquierda, signo de la cuerda T carotidea y segmento M1 izquierdo, y escaso borramiento del lenticular izquierdo ASPECTs 9-10. Se realizó posteriormente angioTC de cerebro y cuello en que se constata oclusión trombótica de T carotidea hasta segmneto M1 distal con persistencia de colaterales. Se deriva a HHM para coordinación eventual trombectomia mecánica en ventana extendida.
Se derivó a HGGB donde se constató core de infarto de 4 ml (CBF menor 30% 4cc, Tmax mayor 6s 39cc) por lo que se intentó trombectomía mecánica en ventana extendida sin embargo posterior a 4 pasadas aspiración con abundante contenido trombótico, no se logra repermeabilización considerándose frustra. Se traslada a UTI de HSC para cuidados posteriores.
Durante la hospitalización se mantiene estable, con FC dentro de rango con ajuste leve de betabloqueo y buen perfil de presiones arteriales, afebril. Evaluación por fonoaudiología se mantiene con SNG.
Se toma conocimiento formal del caso el 25/09/23 paciente de cuidado, en buenas condiciones generales, afebril, hemodinamia estable, sin apremio ventilatorio y sin requerimientos de O2 suplementario. Sin fluctuación neurológica, sin eventos sugerentes de crisis.

Neurológico:
En cuanto al estudio con fibrilación auricular, considerando que se encontraba con DOAC al momento del infarto se plantea la posibilidad de condición protrombótica asociada (trombofilia, paraneo, etc.) se considera estudio en forma diferida una vez mejor de cuadro agudo actual.

Por extensión de infarto se decide manejo osmotico con NaCl 3% que se mantiene hasta el día 4to sin progresar con gran efecto de masa. Se suspende anticoagulación en forma indefinida hasta determinar funcionalidad final. Se mantiene en forma estacionaria en cuanto al déficit neurológico, con alteración de lenguaje y debilidad severa de HC derecho.
Evaluada por fonoaudiología con buena mecánica deglutoria por lo que se mantiene durante gran parte de hospitalización con régimen oral tipo papilla, sin embargo en ultima semana con rechazo de alimentación y somnolencia en relación a intercurrencias infecciosas por lo que se reintala SNG para asegurar aporte. Logra sedente en borde de cama con máxima asistencia.

Infeccioso:
Durante hospitalización cursó con 2 intercurrencias infecciosas. infección de tracto urinario por E faecium resistente a vancomicina que se trata por 7 días con Linezolid logrando disminución de parámetros inflamatorios y sin nuevos episodios de fiebre. Secundario al uso de linezolid cursó con hiponatremia transitoria que se restituye sin otras complicaciones.
El 09/10/23 cursa febril, con aumento de secreciones bronquiales se solicitó culiv de secreción bronquial con desarrollo de E asburiae, K oxytoca, E kobei que se trata por 7 días con Ceftriaxona con regersión de parametros inflamatorios. Se decide completar 12 días, continuando con tratamiento oral.

Urológico:
Desde primer día de hospitalización con episodios de retención urinaria secudarios a vejiga neurogénica, se mantiene durante la hospitalización con sondeo vesical intermitente y aporte de tamsulosina sin lograr micción espontánea por lo que finalmente previo a alta se instala CUP.
Considerando resolución de intercurrencias infecciosas, buen pronóstico deglutorio a corto plazo, se decide continuar con hospitalización domiciliaria.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo pasar a sillón según tolerancia.
2. Régimen papilla lento, líquidos claros, fraccionado, bien sentada y bien despierta. mantener sentada a 90 grados 30 minutos posterior.
3. Se mantiene SNG en caso de no lograr volumen de ingesta.
4. Aspirina 100 mg, 1 comprimido al día, SNG.
5. Atorvastatina 40 mg, 1 comprimido al día, SNG.
6. Bisoprolol 2,5 mg 4 comprimidoa al día, SNG.
7. Tiamazol 10 mg, 3 comprimidos al día, SNG.
8. Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos cada 12 horas, SNG.
9. Bromuro ipratropio 2 puff cada 6 horas con aerocámara.
10. Tamsulosina 0,4 mg, 1 comp al día, SNG.
11. losartan 50 mg, 1/2 comp cada 12 horas, SNG.
12. Cotrimoxazol forte, 1 comp cada 12 horas por 5 días, SNG.
13. Cuidados de CUP
14. Kinesioterapia motora y respiratoria
15. Rehabilitación fonoaudiológica
16. Control GES neurología en HSC
17. Control en caso de necesidad en servicio de urgencias en caso de necesidad. Se explican situaciones de reconsulta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 17/10/23 alb 2.7, Creat 0.5, MDRD 121, Uremia 16, BUN 7, ELP 139/3.8/104, Hb 11.3, hto 33.3, Leuco 6100, plaq 258.000, PCR 36.0, procalc 0.04
- 14/10/23 Creat 0.4, Uremia 27, ELP 138/4.2/105, PCR 80, Procal 0.07
- 10/10/23 CSB desarrollo E asburiae, K oxytoca, E kobei
- 05/10/23 UC Enterococcus faecium resistente a vancomicina
- 03/10/23 Creat 0.6, MDRD 98.55, Uremia 63, BUN 29, ELP 144/4.6/107, Hb 11.7, Hto 37.1, Leuco 11800, plaq 351.000, VHS 42, PCR 48. Procalc 0.09
- 02/10/23 Glic 112, Creat 0.7, MDRD 82.49, ELP 141/4.4/103, Hb 12.3, Hto 39.2, leuco 14400, Plaq 359.000, VHS 48, PCR 33.9, Lactato 1.2
- 29/09/23 Glic 117, Creat 0.6, MDRD 98.55, Uremia 49, BUN 23, ELP 147/4.0/110, Hb 11.0, Hto 34.3, Leuco 9000, plaq 262.000, VHS 32, PCR 45.6

- 29/09/23 TC de encéfalo sin contraste: sin cambios respecto a estudio del 27/09/23, sin trasnformación hemorrágica.
- 28/09/23 Glic 135, Creat 0.5, MDRD 121, Uremia 35, BUN 16, ELP 153/3.8/118, Hb 10.7, Hto 33.6, leuco 7600, Plaq 224.000, VHS 32, PCR 74.2. Procalc 0.08
- 27/09/23 TC de encéfalo sin contraste: consolidación de infarto sin progresión de efecto de masa.
- 27/09/23 Alb 3.1, Creat 0.5, Uremia 32, BUN 15, ELP 145/4.2/111. Hb 11.4, hto 34.3, Leuco 8600, Plaq 179.000, VHS 30. PCR 128.3
- 26/09/23 Creat 0.6, MDRD 98.55, uremia 30, BUN 10, ELP 138/3.9/104, Hb 11.8, Hto 35.5, Leuco 9900 (segm 78%), plaq 158.000, VHS 12, PCR 64.2
- 25/09/23 TC de encéfalo sin contraste: Consolidación de infarto territorio profundo y superficial de ACM izquierda con efecto de masa y desplazamiento de linea media. Sin transformación hemorrágica.
- 25/09/23 ELP 135/4.0/100, PCR 36.1 HC I, HC II, UC, y CSB pendientes.
- 25/09/23 EcocardioTT: sin trombos intracavitarios.
- 25/09/23 Creat 0.6, MDRD 98.6, ELP 139/3.8/108. TSH 0.165, T4L 1.03
- 23/09/23 angioTC de cerebro y cuello: oclusión trombótica de T carotidea hasta segmneto M1 distal con persistencia de colaterales
- 23/09/23 Glic 99, Creat 0.7, MDRD 82.49, Uremia 49, ELP 142/4.5/105, Hb 14.4, Hto 44.1, Leuco 8000, Plaq 154.000. PCR 21.4, Lactato 0.9, P hepatico normal. INR 1.02, TTPa 20. ColT 127, HDL 58, LDL 38, TGL 156. VitB12 276. VitD 11.0. UC negativo.
- 23/09/23 TC de encéfalo sin contraste: lesión secuelar antigua parietal posterior izquierda, signo de la cuerda T carotidea y segmento M1 izquierdo, y escaso borramiento del lenticular izquierdo ASPECTs 9-10

OBSERVACIONES:

Al examen neurológico:
SV FC 92 lpm RII, PA 129/91 mmHg, Sat 85-95 % amb, T° 36.2 °C, HGT 105
- Mental: Vigil, afasia global, nomina 0/3, repite 0/3, no sigue ordenes
- PC: pupilas isocoricas, RFM +/+, hemianopsia densa hemicampo derecho, mirada preferente izquierda logra excursión completa, hipoestesia algésica hemicara derecha, corneal disminuido a derecha, PFC derecha. Resto no evaluable
- Motor: Hemiparesia BC derecha severa. Braquial M0, crural M3 al dolor. ROT normales. plantar derecho extensor
- Sensitivo: hipoestesia algésica severa braquial derecha, moderada crural derecha
- Cerebelo: no evaluable.
- Signos meningeos negativos.

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO